内科含诊断 + 外科 胸膜疾病 ★★★（1~5 题）

气胸



首选 X 线：弧形细线条外无肺纹理透亮区（内 2018、2023）

自发性气胸
（“运或不运功”等突发胸痛、继之呼吸困难，内 2009、2018、2022）

- 原发性：多见于瘦高男性青壮年
- 继发性：COPD、肺结核、肺癌、肺脓肿、肺纤维化等

（外 2007、2011、2013、2019、2024、2025）

	别称	破口	胸膜腔内压	特点	急救
闭合性	单纯性	已闭合	＜大气压	纵隔可不移位	压缩量＜ 20% 观察、否则穿刺抽气
开放性	交通性	吸吮样（自由进出）	= 大气压	纵隔扑动（纵隔在吸气时移向健侧）“开摆”	呼气末堵破口变开放为闭合
张力性	高压性	活瓣（只进不出）	＞大气压	多有脉速、纵隔及皮下气肿	威胁最大→立即穿刺抽气

体征（内 2007、2011、2013、2018、2022、2023）

胸廓饱满、肋间隙增宽、呼吸音和语音震颤减弱或消失、多无啰音
肺下界移动度减小或消失、纵隔（气管 / 心脏）可向健侧移位
心尖搏动减弱或消失（左侧大量）、振水音（液气胸）

- 胸腔积液 —— 胸膜摩擦音 - 胸膜炎（积液量较少）、浊音或实音、肺下界上移
  积液上方可闻及异常支气管（管样）或支气管 - 肺泡呼吸音
- 气胸 —— 鼓音、Hamman 征（左侧少量气胸或纵隔气肿）

胸腔闭式引流（外 2012、2018、2026）

- 气胸：前胸壁锁骨中线第 2 肋间
  胸水：腋中线与腋后线间第 6~7 肋间
- 插管：深呼气后屏气
- 拔管：深吸气后屏气
  “阿西吧”
  - ①肺扩张好 + 无气液排出→拔
  - ②肺不张或有气液排出→不拔
  - ③肺扩张好 + 残留少量气液：引流管通畅→不拔、引流管堵塞→拔

慢性脓胸

- 多长期低热，可伴杵状指、胸廓塌陷、纵隔向患侧移位
- 胸膜纤维板剥脱术

进行性血胸

- 胸腔闭式引流量每小时超过 200ml 并持续 3 小时
- 开胸探查（外 2011）